



智能治疗机

一点一按，让神经电刺激康复更简单



01 产后/床边治疗 的现状



1. 加速康复外科(ERAS)理念成为热门，应用科室涵盖骨科、心胸外科、**妇产科**、泌尿外科、普通外科等领域，均取得了良好效果
- 2 难点痛点：需要足够数量的医务人员

所以说，提高医务人员的工作效率是开展此流程的关键因素之一，给智控机提供了发挥的空间

产后康复治疗在产科临床应用中的具体效果分析

耿庆霞, 张荣秀

济南市第二妇幼保健院 山东济南

(40.95±0.30) W。基本资料对比 $P>0.05$ 。

1.2 方法

常规组: 给予常规产后治疗。先行评估患者的个人状况后, 给予催乳治疗, 积极帮助患者完成子宫复旧治疗, 给予产后恢复指导。

实验组: 给予产后康复治疗。在常规组治疗干预基础上使用产后康复综合治疗仪, 使用前帮助患者调整体位, 检查治疗仪是否能正常运作, 然后在特定位置为其连接电极片, 调整电极片的低频脉冲刺激频数(脉冲强度 100-200), 需积极把控治疗时间(每次 30min 内)。每位患者的电极脉冲强度需按照患者个体状况而调整, 需连续干预治疗 3d-5d, 每天治疗 2 次。

1.3 观察指标

观察两组治疗有效率、产妇康复效果、负性情绪评分。

(1) 治疗有效率评价标准: 总有效率=(显效+有效)/组间数*100%, 干预效果佳数值趋高。显效: 相较治疗前临床症状已消失; 有效: 相较治疗前临床症状改善明显; 无效: 临床症状依旧存在, 或有加重迹象。

(2) 康复效果评价标准: 统计催乳、子宫复旧

治疗有效率, 干预效果佳数值趋高。

(3) 负性情绪评分评价标准: 统计 SAS(焦虑自评量表)、SDS(抑郁自评量表)干预效果佳数值趋低。

1.4 统计

采用 SPSS 23.0 统计软件对数据进行分析, 计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示, 采用 T 检验, 计数资料用率表示, 采用 χ^2 检验, $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗有效率比较

表 1 中, 实验组治疗有效率高于常规组, 对比 $P<0.05$ 。

2.2 产妇康复效果比较

常规组: 催乳有效 38 例、有效率 76.00%; 子宫复旧好 41 例、有效率 82.00%。实验组: 催乳有效 50 例、有效率 100%; 子宫复旧好 50 例、有效率 100%。可见实验组产妇康复效果高于常规组, 对比差值 $\chi^2=13.636$ 、9.890, $P<0.05$ 。

2.3 负性情绪评分比较

表 2 中, 实验组对象负性情绪评分更低, 对比 $P<0.05$ 。

表 1 治疗有效率比较表 $(\bar{x} \pm s)$

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率(%)
常规组	50	21	21	8	84.00
实验组	50	27	22	1	98.00
χ^2					5.982
P					<0.05

表 2 负性情绪评分比较表 $(\bar{x} \pm s)$

理因素、生理因素影响均为影响患者产后康复的主要因素, 故而为避免患者产后出现机体功能性异常、不协调, 需及时给予针对性康复治疗。患者产后常见不良症状会影响其正常产后康复, 例如乳汁无法正常分泌, 主要是由于产妇经手术干预导致机体循环恢复不佳、睡眠质量差、营养摄入不平衡所致^[4-5]。子宫复旧易诱使产后出血, 对其康复促进同样有较大阻碍, 会延长患者的产后康复时间。目前, 临床医学技术不断进步, 产科的产后康复治疗选择也越来越多, 其中产后康复治疗仪被广泛应用于临床后患者个体状况得到显著改善。此产科治疗仪通过对产妇乳房给予刺激, 模拟婴儿的吮吸动作可帮助患者产后内分泌的调节, 对泌乳素与催产素的分泌起到反射性的促进作用, 促进微循环的改善, 保持乳腺管的通畅性, 乳汁正常分泌, 降低产后乳胀发生率^[6-7]。预防乳房血液循环不畅下造成喂养痛苦, 同时可增加个人催产素分泌量提升。治疗子宫复旧, 通过产后康复治疗仪干预使用电极刺激, 加强对盆底肌的刺激防止产妇产后盆底肌肉收缩无力, 可预防淤血加重诱发产后出血风险发生。临床应在评估患者的实际情况后结合个人情况, 规划康复治疗方

案保证科学合理性, 让其更快恢复健康。此类治疗模式的选择旨在为适应医学模式转变而应用, 卫生管、卫生服务职能快速改善的情况下单纯依靠医疗过程中治疗部分的观点以满足不了社会和群众的需求, 那么针对产科的相关康复治疗工作, 开展早期床边康复治疗配合行为是必然推广施治趋势^[8-9]。本次统计中主张将护理服务与物理康复手段进行有机结合, 适时对产妇进行床边无创、无副作用的早期治疗仪机械治疗, 用于帮助产科患者加速预后, 巩固产后康复治疗成果。

结果可见, 实验组临床治疗有效率、产妇康复效果高于常规组; 实验组负性情绪评分低于常规组, $P<0.05$ 。

综上所述, 产后康复治疗在产科临床应用中可提高患者乳汁分泌和子宫复旧康复表现, 平复负性情绪消除影响, 具体效果显著, 未见有毒副作用,

建议产后广泛应用于临床。

参考文献

- [1] 李甜甜. 产后康复治疗在产科的临床应用效果分析[J]. 中国医药指南, 2022, 20(13): 77-79+83.
- [2] 潘琴. 产后康复治疗仪联合乳房按摩对产妇乳房胀痛及泌乳的影响[J]. 医疗装备, 2022, 35(08): 132-134.
- [3] 邓绮雯. 产后康复治疗延伸服务对产褥期产妇产后康复的效果评价[J]. 中国医药科学, 2019, 9(20): 77-79.
- [4] 李永红. 产后康复治疗延伸服务在临床中的效果观察[J]. 湖北科技学院学报(医学版), 2019, 33(03): 258-260.
- [5] 李伟. 产科产后康复干预措施对产后康复的影响探讨[J]. 心理月刊, 2020, 15(08): 132.
- [6] 胡愈芝. 产科产后康复护理干预措施对产后康复的影响效果分析[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(A2): 309-310.
- [7] 王晶. 产后康复治疗在产科的临床应用效果观察[J]. 实用妇科内分泌杂志(电子版), 2019, 6(04): 102-103.
- [8] 杭敏敏. 产科因素对产后盆底的影响及盆底康复治疗疗效[J]. 人人健康, 2018, (24): 9.
- [9] 胡继英. 产后康复治疗结合联合加味生化汤对剖宫产产妇母乳喂养及盆底功能恢复影响[J]. 中外医学研究, 2018, 16(30): 184-186.

收稿日期: 2022 年 6 月 10 日

出刊日期: 2022 年 7 月 15 日

引用本文: 耿庆霞, 张荣秀, 产后康复治疗在产科临床应用中的具体效果分析[J]. 国际内科前沿杂志, 2022, 3(2): 37-39
DOI: 10.12208/j.ijim.20220039

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



快速康复外科护理在剖宫产产妇中的应用效果

陈秀雯

[厦门大学附属妇女儿童医院(厦门市妇幼保健院)产科,福建 厦门 361000]

【摘要】目的:观察快速康复外科护理在剖宫产产妇中的应用效果。**方法:**选取2021年10月至2022年1月该院收治的100例剖宫产产妇进行前瞻性研究,按照随机数字表法分为观察组与对照组各50例。对照组给予常规护理,观察组给予快速康复外科护理,比较两组首次下床活动时间、肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间、产后泌乳时间、负性情绪[汉密尔顿焦虑量表(HAMA)与汉密尔顿抑郁量表(HAMD)]评分、并发症发生率和护理满意度。**结果:**观察组首次下床活动时间、肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间和产后泌乳时间均短于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$);护理后,两组HAMA、HAMD评分均低于护理前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$);观察组护理满意度为96.00%,明显高于对照组的80.00%,差异有统计学意义($P<0.05$);两组并发症发生率比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。**结论:**快速康复外科护理应用于剖宫产产妇可缩短首次下床活动时间、肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间和产后泌乳时间,降低负性情绪评分,以及提高护理满意度,效果优于常规护理。

【关键词】快速康复护理;剖宫产;肠鸣音恢复;肛门排气;产后泌乳;负性情绪;护理满意度

doi: 10.3969/j.issn.1672-0369.2023.14.054

中图分类号: R473.71 文献标识码: B 文章编号: 1672-0369(2023)14-0181-03

Application effects of rapid rehabilitation surgical nursing in cesarean section parturients

CHEN Xiuwen

[Department of Obstetrics of Xiamen University Affiliated Women and Children's Hospital (Xiamen Maternal and Child Health Hospital), Xiamen 361000 Fujian, China]

【Abstract】Objective: To observe application effects of rapid rehabilitation surgical nursing in cesarean section parturients. **Methods:** A prospective study was conducted on 100 cases of cesarean section parturients admitted to this hospital from October 2021 to January 2022. They were divided into observation group and control group according to the random number table method, 50 cases in each group. The control group was given routine nursing, while the observation group was given the rapid rehabilitation surgical nursing. The first ambulation time, the bowel sound recovery time, the first anal exhaust time, the postpartum lactation time, the negative emotion [Hamilton anxiety scale (HAMA) and Hamilton depression scale (HAMD)] scores, the incidence of complications, and the nursing satisfaction were compared between the two groups. **Results:** The first ambulation time, the bowel sound recovery time, the first anal exhaust time and the postpartum lactation time in the observation group were shorter than those in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). After the nursing, the HAMA and HAMD scores of the two groups were lower than those before the nursing, those of the observation group were lower than those of the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). The nursing satisfaction of the observation group was 96.00%, which was significantly higher than 80.00% of the control group, the difference was statistically significant ($P<0.05$). However, there was no significant difference in the incidence of complications between the two groups ($P>0.05$). **Conclusions:** The rapid rehabilitation surgical nursing in cesarean section can shorten the first ambulation time, the bowel sound recovery time, the first anal exhaust time and the postpartum lactation time, reduce the negative emotion scores, and improve the nursing satisfaction. Moreover, it is superior to the routine nursing.

【Keywords】 Rapid rehabilitation nursing; Cesarean section; Bowel sound recovery; Anal exhaust; Postpartum lactation; Negative emotion; Nursing satisfaction

剖宫产是产科常见的分娩方式^[1],提高护理质量有利于改善剖宫产产妇的生命质量^[2]。快速康复外科护理是指在围手术期采用循证医学证实有效的护理措施,以减轻患者心理和生理创伤应激反应,可促进患者康复^[3]。本文观察快速康复外科护理在剖宫产产妇中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年10月至2022年1月本院收治的100例剖宫产产妇进行前瞻性研究。纳入标准:具备剖宫产分娩指征,行剖宫产;临床资料完整;精神状态正常,认知及沟通能力良好。排除标准:凝血功能障碍。产妇及家属对本研究内

复外科护理以患者为中心,可通过围手术期护理措施帮助患者获得快速康复^[8]。研究指出,快速康复外科护理用于计划性剖宫产产妇中效果理想,可促进产妇恢复^[9]。

本研究结果显示,观察组首次下床活动时间、肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间和产后泌乳时间均短于对照组,护理后HAMA、HAMD评分低于对照组。分析原因为快速康复外科护理中,术前缩短禁饮禁食时间可提高产妇舒适度,有效降低产妇口渴、饥饿以及焦虑等主观不适,减轻其负性情绪;术中加用保温毯维持产妇正常体温可避免术中低体温的发生;术后早期活动指导可使产妇各系统功能保持良好状态,预防并发症发生,促进其术后恢复;术后6h待产妇清醒后指导其饮用少量温水可促进其胃肠功能恢复;温毛巾清洁乳房,并进行乳房按摩有利于疏通乳管,促进乳汁顺利排出^[10-11]。

本研究结果同时显示,观察组护理满意度高于对照组,这一结果与文献报道相吻合^[12]。分析原因为快速康复外科护理可加强护患沟通,提高产妇舒适度,促进产妇康复^[13-15]。本研究结果还显示,两组并发症发生率比较,差异无统计学意义。提示采用快速康复外科护理未增加安全风险。

综上所述,快速康复外科护理应用于剖宫产产妇可缩短首次下床活动时间、肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间和产后泌乳时间,降低负性情绪评分,以及提高护理满意度,效果优于常规护理。

参考文献

[1] 杨苗苗,覃敏静,罗春苗,等.快速康复外科理念对计划性剖宫产术后产妇早期下床活动的影响[J].当代护士(综合版),

2021, 16(5): 194-196.

[4] 张锦芳,赵敏庆,唐艳,等.快速康复外科护理预防腹腔镜子宫剖宫产术后腹胀的效果观察[J].实用临床护理学电子杂志, 2020, 5(26): 140.

[5] 林常芳.快速康复外科理念下早期离床对剖宫产患者术后康复的影响[J].当代护士:下旬刊, 2021, 28(10): 94-95.

[6] 韩金凤.快速康复外科护理对剖宫产术后产妇胃肠功能及下肢深静脉血栓形成的影响[J].基层医学论坛, 2020, 24(15): 2154-2155.

[7] 赵小军.围术期快速康复理念护理对计划性剖宫产产妇深静脉血栓的影响分析[J].中外医疗, 2020, 39(24): 154-155, 161.

[8] 王艳艳,陈淑惠,林志琼,等.多学科团队合作加速康复外科理念护理对小儿腹腔镜阑尾术后疼痛及康复的影响[J].国际医药卫生导报, 2021, 27(10): 1558-1560.

[9] 张引莲,谢亚丽,刘娜娜,等.基于快速康复外科理念的护理策略对计划性剖宫产产妇术后恢复情况的影响[J].临床医学研究与实践, 2021, 6(16): 184-186.

[10] 赵方,王钊.快速康复理念联合心理护理对剖宫产患者术后恢复的影响及卫生经济学分析[J].山西医药杂志, 2020, 49(20): 2837-2839.

[11] Rao L, Liu X, Yu L, et al. Effect of nursing intervention to guide early postoperative activities on rapid rehabilitation of patients undergoing abdominal surgery: A protocol for systematic review and meta-analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2021, 100(12): 24776.

[12] 汪丽君.基于快速康复外科理念的干预计划在剖宫产产妇术后生存与康复质量中的作用分析[J].中国基层医药, 2020, 27(12): 1517-1520.

[13] Feng W, Zhou J, Lei Y, et al. Impact of rapid rehabilitation surgery on perioperative nursing in patients undergoing cardiac surgery: A meta-analysis[J]. J Card Surg, 2022, 37(12): 5326-5335.

[14] 郑莹莹,刘小兰,陈静,等.脊柱手术患者围手术期采用快速康复外科护理的临床效果及降低并发症发生率的影响[J].



02

设备功效



一键选择方案，立即开始治疗

圆爱康公司为方便临床，推出智能治疗机:医护只需一个便携控制终端，即可管理院内十几台甚至更多台的电刺激治疗设备，真正做到简单方便，将宝贵的医护资源从烦杂的重复性工作中解脱出来，单位时间内可以服务更多的患者。

点一下:蓝牙连接，点两下:选择方案。

智能治疗机会按照设定的治疗方案开始对患者进行治疗，治疗结束后自动关机，可以覆盖医院各种科室的院内治疗的需求。



后台
更新方案

设备
蓝牙连接

数据
互联互通

治疗
一键启动

智能治疗机是一款可便携使用的神经电刺激设备。可同多种类型的电极探头和电极片连接使用，可为患者进行多项目多方案的康复治疗。



神经肌肉电刺激

通过脉冲电流刺激特定肌肉群，以达到“功能”修复的目的。

神经肌肉电刺激可用于治疗多种疾病，包括神经损伤、肌肉疾患、关节炎和疼痛等。

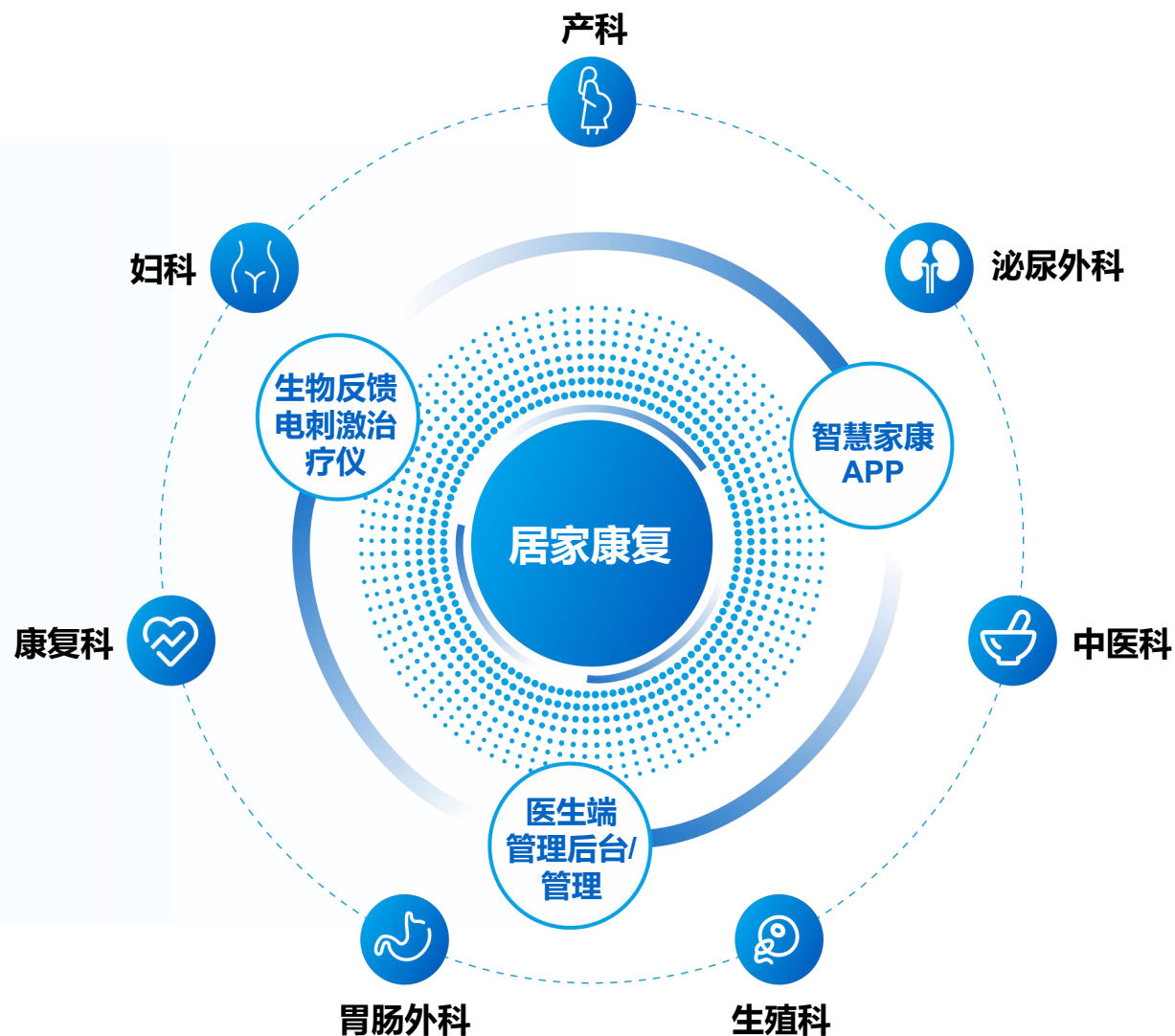




多科室、多项目可用

>>> 协同居家康复—多科开展

产品可覆盖**妇科、产科、泌尿外科、胃肠外科、生殖科、中医科和康复科**的患者，实现对盆底肌、腹直肌、脊骨、骨盆、全身整体的康复治疗。同时，智慧家康积极跟医院深度合作，布局线下实体医疗场景，“三位一体”为患者提供盆底康复治疗方案。



智能治疗机 部分治疗

智能治疗机搭载了各种各样的康复治疗项目，可以单机康复治疗，也可多机协同共同进行治疗，使用简单，适用于医院各个科室，“一键”即可开始。

产科

腰背痛综合治疗、产后子宫复旧、泌乳治疗、乳腺疏通、产后宫缩痛、产后水肿、腹直肌分离、耻骨联合分离、坐骨神经痛、肩颈痛治疗、肌肉酸痛、静脉曲张

妇科/康复科/妇保科

痛经治疗、腰背痛综合治疗、坐骨神经痛、肩颈痛治疗、肌肉酸痛、静脉曲张、慢性盆腔炎、盆底康复、术后康复、腹直肌分离

人流术后

人流术后镇痛、人流术后子宫复旧、人流术后子宫内膜恢复、人流术后卵巢恢复、人流术后月经过少

生殖中心/优生优育治疗

子宫壁增厚治疗、促进子宫内膜血供、促进卵巢血供、卵巢低反应、卵巢储备功能下降

普外科术后康复治疗

术后尿潴留治疗、术后疼痛治疗、术后排气、胃肠排气、吞咽困难治疗、肌肉萎缩治疗

泌尿科/肛肠科/胃肠外科

尿潴留康复、泌尿科盆底康复、泌尿科直肠康复、胃肠排气、便秘、大便失禁

社区康复/社区术后康复治疗

吞咽困难治疗、肌肉萎缩治疗

生殖子宫内膜养护

腹直肌分离

子宫复旧

人流后康复

盆腔器官脱垂

会阴伤口疤痕疼痛

01

妇科

乳汁不足

乳汁淤积

子宫复旧

产后尿潴留

腰背疼痛

镇痛

02

产科

膀胱过度活动症

尿潴留

直肠康复

胃肠排气

便秘

大便失禁

03

泌尿科/肛肠科/
胃肠外科



03

设备使用流程



- 1.选择机器编号，连接蓝牙
- 2.选择治疗方案
- 3.开始治疗





我们用心呵护你的健康。

